Procedimentos Operacionais dos Laboratórios de Saúde, Beleza, Estética e Podologia

Centro de Referência em Inovação Profissional Senac Hub Academy

Senac MS - DEEPE

Revisão: 01 – 12/06/2023

Elaborador: Equipe técnica Senac Hub Academy

Público alvo: alunos e docentes

Necessário treinamento? Não

Resultados esperados: alunos e docentes preparados para quanto aos procedimentos operacionais a serem adotados nos ambientes supra citados.

INTRODUÇÃO 3
PO Nº 01 - NORMAS DE BIOSSEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO 4
PO Nº 02 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - SIMPLES 7
PO Nº03 - FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA ... 12
PO Nº 04-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 16
POP Nº 05 - LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO 29
POP Nº 06 - TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU ARTIGOS PARA DESCONTAMINAÇÃO 40
PO Nº 07 - DESCONTAMINAÇÃO DE ARTIGOS CRÍTICOS..... 42
PO Nº 08 - DESCONTAMINAÇÃO DE ARTIGOS SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS. 47
PO Nº 09 - ARTIGOS DE USO ÚNICO 50
PO Nº 10 - RESÍDUOS DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 52
PO Nº 11 - SIMBOLOGIA DOS TIPOS DE RESÍDUOS..... 60
PO Nº 12 - ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS..... 64
POP Nº 13 - NORMAS INTERNAS PARA ACIDENTES..... 73
ANEXO 1 - TABELA LIMPEZA DOS AMBIENTES..... 79
ANEXO 2 - DESINFECÇÃO ESCOVAS E PENTES 81
ANEXO 3 - DESINFECÇÃO PINCÉIS DE MAQUIAGEM..... 82
ANEXO 4 - COLETA E TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS..... 83
ANEXO 5 – TELEFONES ÚTEIS..... 86

INTRODUÇÃO

O SENAC MS, consolida a Educação Profissional de seus alunos através da ação, reflexão, ação, proporcionando uma aprendizagem significativa, em conformidade com as necessidades exigidas pelo mercado de trabalho e em consonância com as normas técnicas e portarias vigentes.

As práticas desenvolvidas nos Laboratórios de Aprendizagem dos cursos de Saúde, Beleza, Estética e Podologia primam pela segurança e cuidado com os envolvidos no processo ensino - aprendizagem, garantindo assim o exercício das Boas Práticas.

O Manual de Procedimentos Operacionais, contempla os cuidados com os ambientes, materiais, instrumentais e produtos.

PO Nº 01 - NORMAS DE BIOSSEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO		Emitido: 01/09/2020. Próxima revisão: Nº da revisão: 01/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

1.0 Conceito:

Norma é um conjunto de padrões, regras e diretrizes abordadas de forma simples, contendo orientações comportamentais ou especificações técnicas ou outros critérios que devem ser seguidos ou respeitados.

1.1 Objetivo:

Definir normas para a permanência nos laboratórios de ensino, destinados aos cursos de Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

1.2 Responsabilidade:

Docente e Discente.

1.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

1.4 Material necessário:

Nenhum

1.5 Procedimento:

A) O laboratório de ensino é um lugar de trabalho e aprendizado, nunca utilize para outros fins. Este ambiente exige concentração e bom desempenho devido a riscos de acidentes. Para tanto, o aluno precisa seguir as recomendações e instruções fornecidas pelo docente. O aluno só poderá adentrar ao ambiente com a presença do docente, mantendo o mínimo de ruídos possível no local durante as atividades práticas.

B) Os **dispositivos móveis** deverão permanecer desligados ou mantidos no silencioso. Cabe ao docente responsável pelos alunos, a autorização para uso do aparelho em atividades de aula remotas.
C) A Higienização das mãos, com água e sabão é obrigatória ao adentrar e ao sair do laboratório de ensino. A degermação com álcool 70% deverá ser realizada sempre que necessário. Orientar a não realização durante procedimentos com produtos inflamáveis.
D) As roupas precisam ser adequadas, como calça comprida, sapato fechado. Não é permitido durante as aulas, ou uso de bonés, shorts, sapatos abertos, saias curtas (saias longas somente com autorização do docente), jalecos abertos, acessórios (brincos, pulseiras, relógios, correntes.) quando usar jalecos e/ou avental, estes devem permanecer fechados. Conservar os cabelos compridos presos. **O jaleco e/ou avental não deve ser utilizado fora do ambiente de aprendizagem.**
E) Não é permitido mascar chiclete, comer, beber ou fumar no ambiente de aprendizagem.
F) A Guarda e conservação dos produtos, aparelhos e materiais, é da responsabilidade de todos durante as aulas práticas. Quando houver quebra ou danos destes materiais ou aparelhos, o aluno deve comunicar imediatamente ao docente.
G) Todo material reutilizável, utilizado pelos alunos deverá ser devolvido devidamente limpo ao local de origem.
H) Materiais de uso único deverão ser devidamente descartados em local adequado. (Seguir a sinalização do ambiente).
I) É terminantemente proibido o descarte de materiais sólidos, produto químico ou biológico dentro da pia.

J) Os resíduos do tipo comum, químico e biológico deverão ser descartados, conforme estabelecido no PO 5.0.

K) É proibido filmagem e fotografias durante as aulas teóricas e práticas sem autorização do docente**.**

O Uso de EPI´s deverá seguir as normas estabelecidas no PO 4.0.

1.7 Referências bibliográficas:

Desenvolvimento interno.

PO Nº 02 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - SIMPLES		Emitido: 01/09 /2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

2.0 Conceito:

Ato de Higienizar as mãos com Sabonete líquido.

2.1 Objetivo:

Padronizar as ações de higienização das mãos na entrada e saída dos laboratórios de ensino.

Remover a sujidade, a oleosidade, o suor e outros resíduos.

Remover a microbiota transitória.

Prevenir a transmissão de micro-organismos patogênicos.

Promover segurança aos clientes, aos alunos, docentes e colaboradores.

2.2 Responsabilidade:

Docentes e alunos.

2.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

2.4 Material necessário:

Pia apropriada e destinada à higienização das mãos com torneira de acionamento e fechamento manual.

Porta-papel Toalha.

Papel-toalha descartável.

Dispensador removível com antisséptico degermante ou sabão líquido hipoalergênico.

Recipiente para descarte de resíduos comuns com a tampa acionada por pedal.

2.5 Terminologia:

Antissepsia - trata-se da redução da microbiota residente e da eliminação da microbiota transitória com a ajuda da solução com propriedade germicida denominada antisséptico em uma superfície viva. Ex: mãos.

2.6 Procedimento:

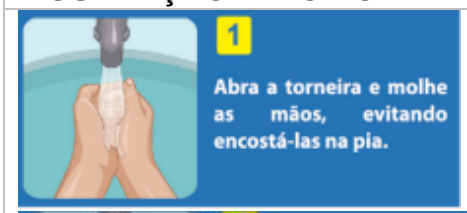
Frequência de higienização das mãos:

A) Antes de iniciar as atividades;
B) Imediatamente após o uso do sanitário;
C) Ao tossir, espirrar ou assuar o nariz;
D) Após a manipulação de material contaminado e depois de retirar o lixo;
E) Antes e após o uso das luvas;
F) Antes e após manusear cada cliente e, eventualmente, entre as atividades realizadas em um mesmo cliente;
G) Depois de usar qualquer produto químico;
H) Ao pegar em dinheiro;
I) Todas as vezes estiverem sujas e em todos os momentos necessários;
J) Antes e após manusear alimentos;
K) Antes e após o uso de equipamentos de proteção individual;
L) Após aplicações consecutivas da solução alcoólica nas mãos;
M) Após atividades práticas de qualquer procedimento realizado dentro dos laboratórios.

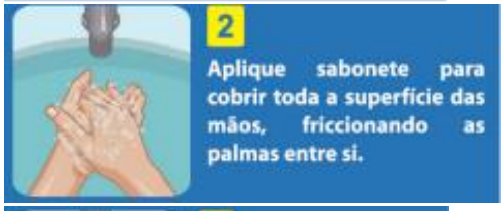
Técnica de Higienização das Mãos:

A) Tempo de execução: 40 a 60 segundos, mínimo.
B) Conferir a presença de solução antisséptica degermante ou sabonete líquido e de papel-toalha.
C) Retirar Adornos (anéis, pulseiras, relógio).
D) Dobrar os punhos do vestuário, se necessário.
E) Posicionar-se em frente à pia, sem encostar-se nela.
F) Abrir a torneira.
G) Molhar as mãos e punhos. Aplicar, na palma da mão, quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos - mais ou menos 5 ml do produto.
H) Ensaboar as palmas das mãos friccionando-as entre si.
I) Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa.
J) Entrelaçar os dedos e friccione os espaços interdigitais.
K) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vai-e-vem e vice-versa.
L) Esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando-se de movimento circular e vice-versa.
M) Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa.
N) Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, realizando movimentos circulares, e vice-versa.
O) Enxaguar as mãos, iniciando pelas pontas dos dedos em direção ao punho com água corrente, retirando os resíduos de sabonete.
P) Evitar o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.
Q) Secar as mãos com papel toalha e após os punhos.
R) Fechar a torneira com o papel toalha, se a torneira não possuir fotossensor.
S) Desprezar o papel-toalha no recipiente de descarte para resíduos comuns.

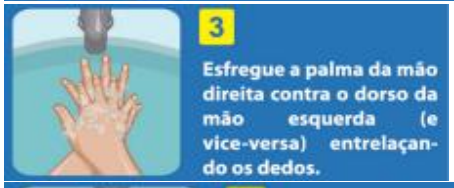
ILUSTRAÇÃO: TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.



1 Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostá-las na pia.



2 Aplique sabonete para cobrir toda a superfície das mãos, friccionando as palmas entre si.



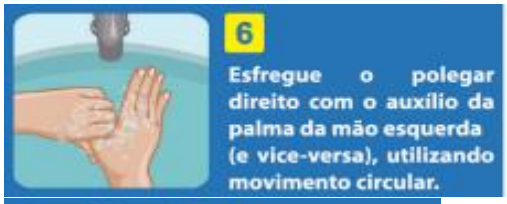
3 Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.



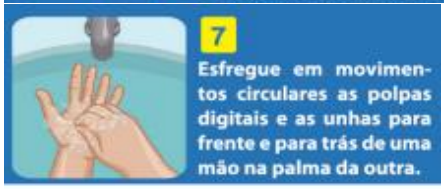
4 Entrelace os dedos palma com palma e friccione os espaços interdigitais.



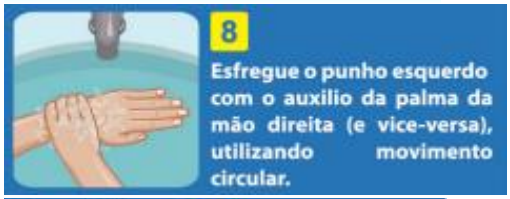
5 Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vai e vem.



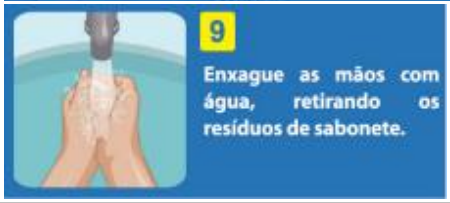
6 Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.



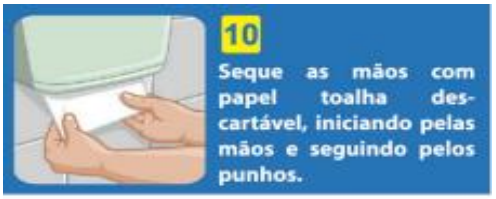
7 Esfregue em movimentos circulares as polpas digitais e as unhas para frente e para trás de uma mão na palma da outra.



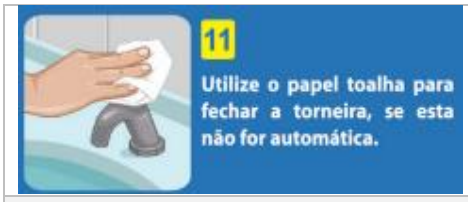
8 Esfregue o punho esquerdo com o auxilio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.

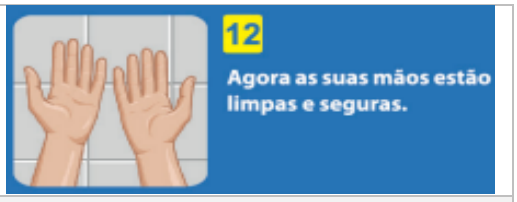


9 Enxague as mãos com água, retirando os resíduos de sabonete.



10 Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.





2.7 Referências:

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº05/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA: ORIENTAÇÕES GERAIS PARA HIGIENE DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. 2020, 40p.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 168p. 3. BRASIL.
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 122p.

PO Nº03 - FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA		Emitido: 01/09/2020 Próxima revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

3.0 CONCEITO:

Higienização das mãos com o uso de Antisséptico Hidroalcoólico.

3.1 Objetivo:

Padronizar as ações de Higienização das mãos com o uso de Antissépticos Hidroalcoólicos, nos ambientes de Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

Prevenir a transmissão de micro-organismos patogênicos.

Fornecer opção adicional à higienização das mãos.

Promover segurança ao cliente e aos profissionais.

Reduzir a carga microbiana das mãos, podendo substituir a higienização com água e sabão, quando as mesmas não estiverem visivelmente sujas.

3.2 Responsabilidade:

Docentes e Alunos.

3.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

3.4 Material necessário:

Dispensador com solução hidroalcoólico (gel, solução ou espuma na concentração de 70%).





FIG.3.1 Tipos de dispensadores para solução hidroalcoólico: Totem com pedal / Fixo de parede / Em Frasco tipo Almotolia.

3.5 Terminologia:

Antissepsia - trata-se da redução da microbiota residente e da eliminação da microbiota transitória com a ajuda da solução com propriedade germicida denominada antisséptico em uma superfície viva. Ex: mãos.

3.6 Procedimento

TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICO A 70%

1. conferir a presença de solução antisséptica hidroalcoólico.

2. Retirar os adornos (anéis, relógios e pulseiras).

3. Dobrar os punhos do vestuário, se necessário.

4. Colocar uma das palmas das mãos sob o jato do dispensador de gel antisséptico hidroalcoólico (Figura 1).

5. Acionar o dispensador com a outra mão, aplicando quantidade da preparação suficiente para cobrir a superfície de ambas as mãos (3 a 5 ml) (Figura 1).

6. Friccionar as palmas das mãos entre si. (Figura 2).

7. Friccionar a palma de uma das mãos contra o dorso da outra, entrelaçando os dedos. Repetir o movimento com a outra mão (Figura 3).

8. Entrelaçar os dedos, palma com palma, e friccionar os espaços interdigitais. (Figura 4).

9. Fechar os dedos das mãos em garra, encaixando-os entre si de maneira que as palmas das mãos esfreguem o dorso dos dedos em movimentos de vai e vem e vice-versa. (Figura 5).

10. Friccionar o polegar de uma mão com a palma da outra, em movimento circular. Inverter as posições e friccionar o outro polegar. (Figura 6).

11. Unir os dedos de uma das mãos e friccionar as pontas destes contra a palma da outra, em movimentos circulares. Repetir o movimento com a outra mão. (Figura 7).

12. Deixar a preparação secar espontaneamente. **Não utilizar papel toalha.**

FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA


Figura 1


Figura 2


Figura 3


Figura 4


Figura 5


Figura 6


Figura 7

Frequência de higienização das mãos com Solução Hidroalcoólico:

1) Antes e após o contato com o cliente;

2) Antes e após o uso de equipamentos de proteção individual;

3) Antes e após realizar procedimentos assistenciais;

4) Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico;

5) Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, independente se este é limpo ou não, durante o cuidado ao cliente;

6) Antes e após remoção de luvas;

7) Após contato com objetos inanimados e superfícies;

8) Antes e após a realização de procedimentos que necessitem da higienização das mãos.

OBSERVAÇÕES:

Friccionar as mãos com a preparação hidroalcoólico durante 20 a 30 segundos. Os álcoois apresentam rápida ação e excelente atividade bactericida e fungicida, porém não têm efeito residual.

Secar as mãos com papel-toalha, quando se encontrarem molhadas, antes de friccioná-las com a preparação alcoólica. A água pode diluir a preparação, tornando-a menos eficaz.

Estabelecer rotina de limpeza, secagem e desinfecção dos dispensadores de solução alcoólica.

3.7 Referências:

1) BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº05/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA: Orientações Gerais para Higiene das Mãos em Serviços de Saúde. 2020, 40p.

2) BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 168p. 3. BRASIL.

3) Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 122p.

PO Nº 04-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Emitido: 01/09 /2020 Próxima Revisão: Nº da revisão:001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

4.0 CONCEITO

EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.

4.1 Objetivo:

Padronizar as ações de Paramentação e Desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S.

4.2 Responsabilidade:

Docente e alunos.

4.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

4.4 Material necessário:

São considerados EPI´S:

Avental e Jaleco

Touca e Gorro

Máscara Cirúrgica

Máscara de proteção respiratória

Óculos de proteção

Face Shield

Luva

4.5 Terminologias:

EPI´S - Equipamentos de proteção individual

4.6 Procedimentos:

1. Avental e Jaleco

Serve para proteger a pele e as roupas do profissional nas diversas atividades laboratoriais (coleta de amostras, manuseio de material biológico ou químico), e no contato com as superfícies, objetos e equipamentos do laboratório que podem estar contaminados.

O Avental ou Jaleco deves ser sempre utilizado durante as atividades práticas, mesmos que os alunos estejam com o uniforme estabelecido pela escola, (Ex. Roupa Branca) pois é considerado uma barreira para as roupas pessoais.

Este deve possuir mangas longas, com punho ajustável de tecido ou descartável.

Após seu uso este deverá ser acondicionado em saco plástico e somente retirado para lavagem.

Cabe aos docentes de cada área a orientação aos alunos sobre a lavagem doméstica enfatizando a não misturar com outras roupas da residência e a Higienização diária da peça utilizada.

TÉCNICA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO:

1. Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.
2. Nunca amarre o avental ou capote pela frente.
3. Vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura. (Fig.01)
4. Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os braços e os punhos. (Fig.02)

5. Abra as tiras e solte as amarras. (Fig.03)
6. Empurre pelo pescoço e pelos ombros, tocando apenas a parte interna do avental/capote. (Fig.04)
7. Retire o avental/capote pelo avesso. (Fig.05)
8. Dobre ou enrole em uma trouxa e descarte em recipiente apropriado. (Fig.06)
9. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

ILUSTRAÇÃO: Tipos de Jaleco e Aventais / Colocando e Retirando.





Fig.01

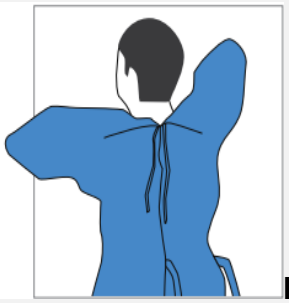


Fig.02



Fig.03



Fig.04

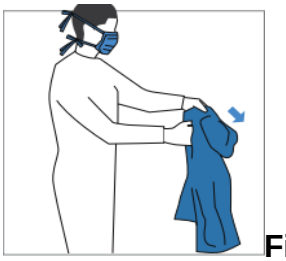


Fig.05



Fig.06

Disposições gerais

Procedimentos de manutenção e conservação de EPI´S

A) Jaleco/Avental - Deve estar limpo na hora do uso em aula/atendimento. Essa Higienização é de responsabilidade de cada aluno.

B) O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade. Permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.

C) O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado como resíduo infectante após a realização do procedimento e antes de sair dos Laboratórios;

D) Após a sua remoção, deve-se proceder a higiene das mãos;

E) Máscaras de tecido são recomendadas, somente para seguir protocolos de segurança;

F) Não reutilizar máscaras descartáveis;

G) Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara;

H) Troque a máscara quando estiver úmida ou sempre que for necessário;

I) Além dos EPIs recomendados para precaução de contato e gotículas, profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, devem utilizar a MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO - N95, PFF2 ou equivalente) e GORRO OU TOUCA;

J) Não se deve circular fora do laboratório de ensino utilizando os EPIs. Estes deverão ser imediatamente removidos após a saída do laboratório;

K) Não largar materiais em cima dos mobiliários do laboratório os mesmos deverão ser acondicionados e guardados ou descartados ao final da aula.

2. Touca ou Gorro:

O uso de gorros ou toucas descartáveis proporciona barreira efetiva para o profissional, contra gotículas ou aerossóis, ou ainda, queda de fios de cabelo sobre a superfície de trabalho. Em caso de cabelos compridos este deverá estar preso antes de sua colocação.

TÉCNICA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO:

1) Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.
2) Colocar o gorro ou a touca na cabeça começando pela testa, em direção à base da nuca.
3) Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas.
4) Sempre que o gorro ou a touca aparentarem sinais de umidade, devem ser substituídos por outro.
5) O Gorro é retirado após o avental ou capote
6) Para retirar a touca/gorro, puxe pela parte superior central, sem tocar nos cabelos.
7) Descarte a touca/gorro em recipiente apropriado.
8) Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

ILUSTRAÇÃO :

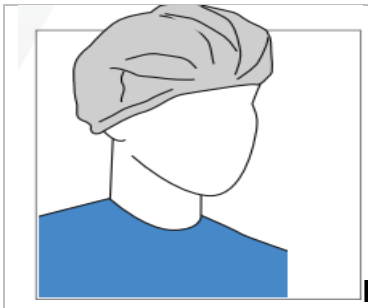


Fig.1 colocar



Fig.2 retirar.

3. Máscara Simples e Máscara Cirúrgica

A Máscara é um equipamento de proteção das vias aéreas superiores e deve também ser escolhida de acordo com o material a ser manipulado, por exemplo, em atividades de manipulação de agentes biológicos patogênicos com alta probabilidade de geração de aerossóis pode ser necessário a utilização das máscaras especiais submicron, com 95% de eficiência.

Máscaras de tecido podem ser usadas para impedir que a pessoa que a está usando, espalhe secreções respiratórias ao falar, espirrar ou tossir (controle de fonte), porém elas NÃO são Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), portanto, não devem ser recomendadas aos alunos como substituição das máscaras descartáveis. Além disso, só devem ser usadas se estiverem íntegras, limpas e secas.

Atenção: NUNCA se deve realizar a limpeza da máscara cirúrgica já utilizada com nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem ser limpas ou desinfetadas para uso posterior e quando úmidas, perdem a sua capacidade de filtração.

TÉCNICA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO:

1) Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.
2) Verifique se a máscara não está danificada.
3) Utilize o clip nasal como referência para identificar a parte superior. Coloque a máscara em seu rosto e prenda as alças atrás da cabeça, mantendo-as paralelas (nunca cruzadas).

4) Aperte o clip nasal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz, visando minimizar espaços entre a face e a máscara.

5) Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo.

6) Durante a retirada da máscara evite tocar a parte frontal, pois ela estará contaminada!

7) Segure as alças inferiores e depois as alças ou elástico superiores e remova-a.

8) Descarte em uma lixeira. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

ILUSTRAÇÃO :

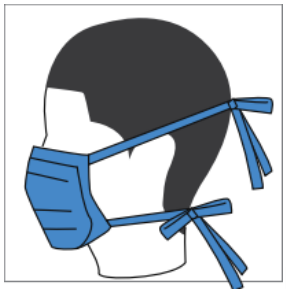


Fig.1

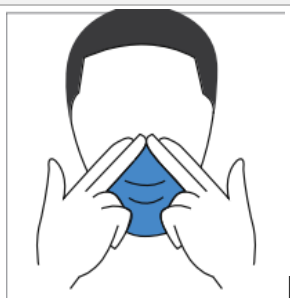


Fig.2

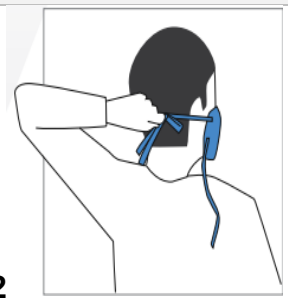


Fig.3

4. Máscara de Proteção Respiratória

Máscaras de alta filtragem do tipo N 95, PFF2 ou equivalente. Com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). São alguns exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais, broncoscopias, etc.

A máscara de proteção respiratória (respirador particulado - máscara N95/PFF2 ou equivalente), deve estar apropriadamente ajustada à face do profissional. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as

recomendações do fabricante e nunca deve ser compartilhada entre profissionais.

A guarda ou descarte deste material é de responsabilidade individual de cada aluno, todos deverão obedecer aos procedimentos recomendados pelo docente, durante o uso.

TÉCNICA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO:

1) Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.
2) Segurar o respirador com o clip nasal próximo à ponta dos dedos deixando as alças pendentes. (Fig.1)
3) Encaixar o respirador sob o queixo. (Fig.2)
4) Posicionar uma das alças na nuca e a outra na cabeça. (Fig.3)
5) Ajustar o clip nasal no nariz. (Fig.4)
6) Verificar a vedação pelo teste de pressão positiva e negativa. (Fig.5)
7) Segurar o elástico superior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça para removê-lo. (Fig.5)
8) Remover a máscara segurando-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna. (Fig.6)
9) Acondicione a máscara em um saco ou envelope de papel com os elásticos para fora, para facilitar a retirada posteriormente, no caso de reutilização.
10) Nunca coloque a máscara já utilizada em um saco plástico, pois ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada.
11) Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

ILUSTRAÇÃO :

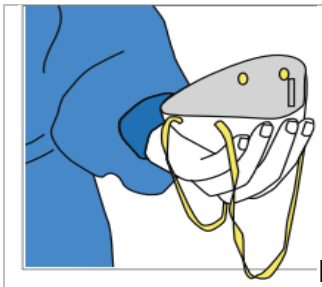

Fig.1


Fig.2


Fig.3

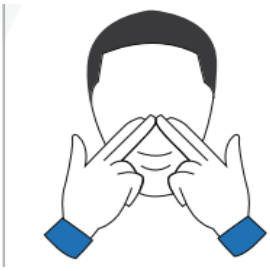
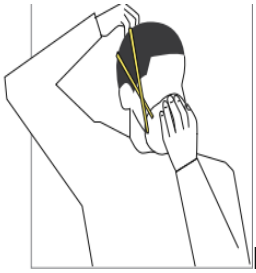

Fig.4


Fig.5


Fig.6

● **Disposições gerais**

A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.

Excepcionalmente, em situações de carência de insumos e para atender a demanda a máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios para a retirada da máscara sem a contaminação do seu interior.

Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95 ou equivalente, se houver disponibilidade, pode ser usado um protetor facial (face Shields).

Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser utilizada várias vezes durante as aulas por um mesmo docente e um mesmo aluno seguindo normas de Biossegurança já informadas neste documento.

5. Óculos de Proteção ou Protetor Facial (FACE SHIELD)

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do Docente e aluno a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc.

Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada Docente e aluno que participa das atividades práticas, devendo, imediatamente após o uso realizar a limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for compatível), Hipoclorito de sódio ou outro desinfetante, na concentração recomendada pelo fabricante. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção. O Docente deverá orientar todos os alunos na realização destes procedimentos.

TÉCNICA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO:

1) Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.
2) Apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico pela parte superior da cabeça. (Fig.1)
3) No caso dos óculos, coloque da forma usual. (Fig.2)
4) Os equipamentos devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo necessária a higiene correta após o uso, caso não possa ser descartado.
5) Sugere-se a limpeza e desinfecção, de acordo com as instruções de reprocessamento do fabricante.
6) Remova pela lateral ou pelas hastes, considerando que a parte frontal está contaminada. (Fig.3)
7) A limpeza e a desinfecção devem ser realizadas de acordo com as instruções de reprocessamento do fabricante.

ILUSTRAÇÃO :

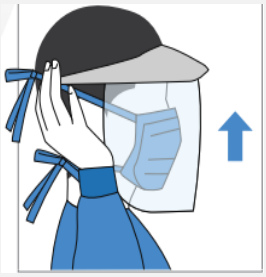
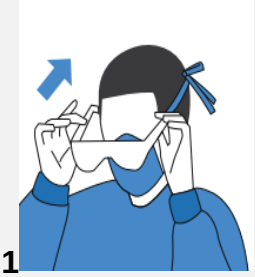
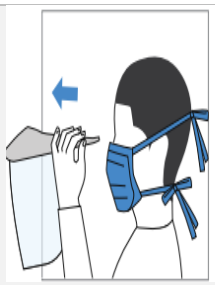

Fig.1

Fig.2


Fig.3

6. Luvas para Procedimentos Descartáveis

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, em qualquer contato com o cliente ou para procedimentos em aulas práticas.

As luvas devem ser colocadas na frente do cliente e antes de iniciar dos procedimentos.

As luvas devem ser removidas, utilizando a técnica correta.

Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.

Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser reutilizadas).

O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.

Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento aos pacientes, esta ação não garante mais segurança à assistência.

TÉCNICA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA

1) Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

2) Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão oposta.

3) Segure a luva removida com a outra mão enluvada.

4) Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem luvas) e retire a outra luva.

ILUSTRAÇÃO:

Quando a higiene das mãos ocorrer antes de um contato que exija o uso de luvas, realize-a com preparação alcoólica ou com água e sabonete.

I. COMO CALÇAR AS LUVAS:



1. Retire uma luva de sua caixa original



2. Toque apenas uma área restrita da superfície da luva correspondente ao pulso (na extremidade superior do punho)



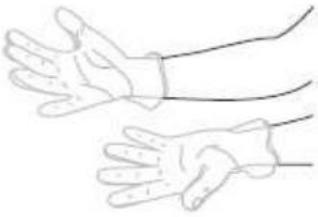
3. Calce a primeira luva



4. Retire a segunda luva com a mão sem luva e toque apenas uma área restrita da superfície correspondente ao pulso



5. Para evitar o contato com a pele do antebraço com a mão calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo assim o calçamento da segunda luva

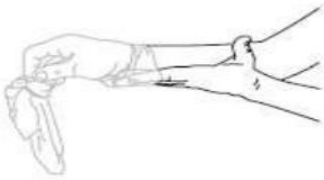


6. Uma vez calçadas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de uso das luvas

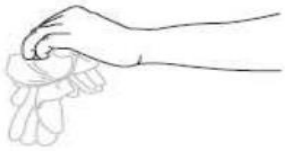
II. COMO RETIRAR AS LUVAS:



1. Toque a parte interna da luva na altura do pulso para removê-la, sem tocar na pele do antebraço, e retire-a da mão, permitindo assim que a luva vire do avesso



2. Segure a luva retirada com a mão enluvada e deslize os dedos da mão sem luva na parte interna entre a luva e o pulso. Remova a segunda luva, rolando-a para baixo sobre a mão e dobrando-a na primeira luva



3. Descarte as luvas retiradas

Em seguida, efetue a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete líquido

4.8 Referências:

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº05/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA: ORIENTAÇÕES GERAIS PARA HIGIENE DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. 2020, 40p.

2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 168p. 3. BRASIL.

3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 122p.

4.Anvisa:notatécnica04/2020.http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTESANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28**.**

POP Nº 05 - LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: Ana Valeria G. Reis Coren MS 72.626	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

5.1 Objetivo:

Definir práticas de condições adequadas para ser realizadas a limpeza e sanitização em todos os laboratórios de ensino.

A limpeza consiste na remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) ou químicos (saneantes), com água e sabão, em um determinado período de tempo. Independentemente da área a ser higienizada, o importante é a remoção mecânica da sujidade e não simplesmente a passagem de panos úmidos para espalhar a sujidade. A escolha das técnicas de limpeza e desinfecção está diretamente relacionada ao tipo de superfície a ser limpa e desinfetada, a quantidade e o tipo de matéria orgânica presente.

5.2 Responsabilidade:

Limpeza e Conservação / logística.

5.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

5.4 Material necessário:

EPI´S (touca e luvas de cano longo e antiderrapantes)

Calçados impermeáveis (botas)

Álcool 70% Detergente

Hipoclorito de Sódio 1%	Baldes / Esponjas / rodos/ panos

5.5 Terminologia:

EPI´S - equipamentos de proteção individual

Assepsia - diminuir/remover a quantidade de microrganismos de uma superfície inanimada.

Limpeza - não mata os microrganismos, mas, ao removê-los, diminui o número e o risco de propagação da infecção.

Desinfecção - refere-se ao uso de produtos químicos para matar microrganismos em superfícies. Esse processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove microrganismos, mas ao matar microrganismos em uma superfície após a limpeza, ele pode reduzir ainda mais o risco de propagação de infecções.

Recomendações:

1) Somente devem ser utilizados produtos regularizados na Anvisa, observado seu prazo de validade. Os rótulos contêm instruções para o uso seguro e eficaz do produto de limpeza, incluindo as precauções que se deve tomar ao aplicar o produto, como usar luvas e garantir uma boa ventilação durante o uso do produto.

2) Devem ser seguidas as instruções do fabricante de cada um dos produtos de limpeza e desinfecção (concentração, método de aplicação e tempo de contato, uso de luvas, etc).

3) Os objetos frequentemente tocados, por exemplo, interruptores de luz, maçanetas, corrimãos, mesas, telefones, controles remotos, teclados, podem ser desinfetadas com álcool 70% ou desinfetantes de uso doméstico. Para equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, computadores, pantalhas táteis, siga as instruções do fabricante para os produtos de limpeza e desinfecção a serem utilizados.

4) Caso nenhuma orientação do fabricante estiver disponível, considere o uso de panos específicos para eletrônicos, umedecidos com álcool isopropílico 70%, de preferência, para desinfetar as telas sensíveis ao toque.

5) Para superfícies duras, como pisos, banheiros, etc., utilizar luvas descartáveis para limpeza e desinfecção. As luvas devem ser descartadas após o uso. Consulte sempre as instruções do fabricante constante no rótulo do produto. Lave as mãos imediatamente após o retiro das luvas.

6) A maioria dos desinfetantes requerem alguns minutos de tempo de contato para inativar microrganismos, de acordo às instruções do rótulo; portanto, a limpeza imediata da superfície após a aplicação do desinfetante não será eficaz no caso de retirada do produto antes do tempo necessário para sua ação.

7) Não devem ser usados os seguintes materiais e equipamentos para desinfecção de superfícies e objetos: vassouras e esfregões secos, pois

as partículas contaminadas podem ser veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.

8) Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos. Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.

9) O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os produtos de higiene, como sabonete e papel toalha e outros são suficientes para atender às necessidades do setor.

10) **Atribuições que NÃO competem ao profissional do Serviço de Higienização.**

A) Recolhimento de perfurocortantes de locais inadequados, como pisos, bancadas e outros.

B) Fechamento de coletores de perfurocortantes.

C) O fechamento de coletores está sob a responsabilidade de quem manipula e descarta os perfurocortantes, geralmente sendo atribuídas à equipe de Docentes e alunos que utilizaram o laboratório, não cabendo essa tarefa à equipe de higienização.

D) Retirada de materiais ou equipamentos provenientes das aulas práticas. São exemplos: bolsas ou frascos de soro, equipos, bombas de infusão, comadres, papagaios, recipientes de drenagens e outros.

11) Antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção do ambiente, ele deve ser organizado de modo que todos os objetos e materiais estejam guardados, liberando. Para fins organizacionais, o ambiente de trabalho pode ser dividido.

ÁREA FÍSICA E SUPERFÍCIES FIXAS	Lixeiras	Pisos	Paredes
	Janelas	Teto	Portas
	Extintor de Incêndio	Maçaneta de porta	Interruptores de Energia
MOBILIÁRIOS	Cadeiras	Armários	Mesas
	Mochos	Macas	Balcões
	Camas	Espelhos	Vidros
	Bancadas	Pias	Vasos Sanitários
EQUIPAMENTOS	Aparelhos telefônicos	Impressoras	Autoclaves e Estufas
	Equipamentos de Enfermagem	Equipamentos de Estética Facial e corporal	Equipamentos de Podologia
	Secadores e Chapinhas	Balanças	Ar condicionado

5.6 PROCEDIMENTOS

• Proceder a frequente higienização das mãos.

• Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, percing) durante o período de trabalho.

• manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte.

• os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita.

• O uso de EPI deve ser apropriado para a atividade a ser exercida. (Máscara / luvas / Avental / Bota / cabelo preso com touca).

• nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.

OBS. Ambientes da Beleza / SALÃO: após atender o cliente, proceder à retirada imediata dos cabelos decorrentes do corte ou escova. Dar preferência à aspiração; tomar cuidado para não espalhar pelo ar.

• utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.

OBS. APARELHOS DE AR CONDICIONADO - DEVERÃO SEGUIR NORMAS TÉCNICAS DETERMINADAS PELA ANVISA E ANBRAVA .

TÉCNICAS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE DOIS BALDES

(Para o profissional responsável pela Higienização)

• Envolve a limpeza com a utilização de panos de limpeza de piso e rodo.

• Facilita o trabalho do profissional de limpeza, evitando idas e vindas para trocas de água e limpeza do pano.

Os seguintes passos são envolvidos nessa técnica de limpeza:

1) Varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.
2) Remover o pó e possíveis detritos soltos no chão, fazendo uso de pano úmido e rodo. Esses resíduos não podem ser levados até a porta de entrada, devendo ser recolhidos do ambiente com o auxílio de pá. Deve-se iniciar a limpeza pelos cantos e de forma profissional e educada, para que as pessoas que estejam no local possam perceber e colaborar, liberando o espaço. Nessa etapa, os dois baldes conterão apenas água.
3) Ensaboar: É a ação de fricção com sabão ou detergente sobre a superfície com a finalidade de remoção de toda sujidade. Realizar movimentos firmes e evitando o “vai-e-vem”. Nessa etapa, um dos baldes conterá água, e outro, sabão líquido ou detergente.
4) Enxaguar e Secar: Tem a finalidade de remover o sabão ou detergente. Nessa etapa, os dois baldes conterão apenas água.
5) Recolher os sacos contendo resíduos do local, fechá-los e depositá-los no local adequado, sem misturar os tipos de resíduos.

6) Realizar a limpeza do local com pano úmido nas mobílias, incluindo as maçanetas das portas, interruptores de luz, dispensadores de soluções e papel e, parapeitos de janelas.

7) Mergulhar o pano de limpeza de piso limpo em um balde contendo solução de água e sabão ou detergente, torcendo suavemente e envolvendo no rodo. A água do balde também deve ser trocada sempre que houver necessidade. Enxaguar o piso, mergulhando um pano limpo em balde contendo apenas água limpa e secar o piso. Repetir a operação quantas vezes for necessário.

LIMPEZA DAS ÁREAS FIXAS E DAS SUPERFÍCIES:

PISO

• Recolher, em lixeira adequada para cada tipo de resíduo, todos os resíduos encontrados;
• Retirar o lixo devidamente ensacado;
• Lavar as lixeiras e substituir os sacos plásticos;
• Retirar quando necessário, mobiliários (cadeiras, mesas, macas, etc.);
• Efetuar a **limpeza** utilizando a técnica de dois baldes;
• Passar pano seco envolvido em um rodo para secar bem o chão.

LIXEIRAS

• Retirar todos os resíduos sólidos;
• Realizar a limpeza das lixeiras com esponja exclusiva e detergente neutro;
• Deixar agir por 15 minutos;
• Esfregar bem e enxaguar;
• Deixar secar naturalmente;

PAREDES, PORTAS, JANELAS e TETO

• Afastar os móveis do local a ser limpo para não danificá-los, retornando-os para o lugar no final da limpeza;
• Iniciar pela limpeza do teto e depois da parede, com movimentos de cima para baixo;
• Utilizar a técnica dos dois baldes.

• Passar pano seco envolvido em um rodo para secar bem.

EXTINTOR DE INCÊNDIO / INTERRUPTORES E MAÇANETAS DE PORTA

- Passar um pano umedecido com água, detergente neutro e hipoclorito de sódio 1%.

LOUÇAS SANITÁRIAS (PIAS E VASOS)

PIAS	VASO SANITÁRIO
Técnica dos baldes; espalhar desinfetante (hipoclorito de sódio 1%) sobre a superfície e esfregar para sanitização do ambiente; lavar as torneiras e o encanamento sob o lavatório; enxaguar a superfície e secar com um pano seco.	Levantar o assento; Dar a descarga; lavar o exterior do vaso, o assento de ambos os lados, dobradiças e partes próximas do chão; esfregar o interior do vaso com a escova própria; enxaguar com água limpa, secar com pano limpo o exterior do vaso, assento e dobradiça; Dar nova descarga; recolher limpar e guardar o material utilizado.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE MOBILIÁRIOS

- Recolher e guardar em local específico ou em bandejas os objetos e materiais que ocupam as superfícies a serem limpas.

LUMINÁRIAS

• Desligar a corrente elétrica;

• Remover a poeira da lâmpada e da luminária com pano úmido;

• Secar bem a luminária e a lâmpada.

ESPELHOS E VIDROS

Fazer a assepsia com pano umedecido em álcool 70%.

CAMAS, CADEIRAS, MOCHOS E MACAS:

Utilizar técnicas dos dois Baldes ⇨ Secar com pano limpo ⇨ Passar álcool a 70%.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

APARELHOS TELEFÔNICOS **E** **IMPRESSORAS**	Limpar com pano úmido ⇩ Secar ⇩ Fazer a assepsia com pano umedecido em álcool a 70% em toda a superfície, incluindo os cabos.
AUTOCLAVE E ESTUFA	**Limpeza externa:** Limpar com pano úmido ⇩ Secar ⇩ Fazer a assepsia com pano umedecido em álcool a 70% em toda a superfície.

COMPUTADORES	• Limpar o monitor e a área externa do PC delicadamente, utilizando uma flanela limpa e seca ou levemente umedecida com água. • No caso do teclado, virá-lo para baixo e bater para que os resíduos mais grossos caiam; passar uma escova de cerdas macias e, em seguida, esfregar um pano umedecido em uma mistura de água e detergente neutro; • Limpar os vãos entre as teclas com uma haste de algodão, Também umedecida com água e detergente neutro; • Finalizar passando outra haste com Álcool isopropílico.

SECADORES / CHAPINHAS E BALANÇAS
Limpar com pano úmido Secar ⇩ Fazer a assepsia com pano umedecido em álcool a 70% em toda a superfície. ⇩ **OBS: RETIRAR OS APARELHOS DA TOMADA / SECADORES E CHAPINHAS DEVERÃO ESTAR COM TEMPERATURA AMBIENTE.**

EQUIPAMENTOS		
DE ENFERMAGEM	**DE ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL**	**DE PODOLOGIA**
DESCONECTAR O APARELHO DA REDE ELÉTRICA ⇩		

PASSAR UM PANO UMEDECIDO COM ÁGUA MORNA E EVENTUALMENTE COM SABÃO NEUTRO.

⇩

OBS: O USO DO ÁLCOOL A 70% PARA ASSEPSIA DOS EQUIPAMENTOS COMO PREVENÇÃO, DEVE SER ADOTADO COM CAUTELA POIS, O PRODUTO PODE DANIFICAR OS APARELHOS TANTO ESTERNAMENTE COMO INTERNAMENTE.

IMPORTANTE

SEMESTRALMENTE deve ser realizado em todos os setores do SENAC, dedetização, desratização e imunização contra traças e outros insetos voadores e rasteiros com empresa apropriada e credenciada para realização deste procedimento.

5.7 Referências:

RAMOS, Janine Maria Pereira. **Biossegurança em estabelecimentos de beleza e afins.** 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

BRASIL, Ministério da Saúde**.** Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa**. Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies.** Brasília, 2010.

POP Nº 06 - TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU ARTIGOS PARA DESCONTAMINAÇÃO		Emitido: 01/09/2020 Revisado: - Nº da revisão: 001
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

6.0 Objetivo:

Orientar e definir os cuidados para evitar acidentes durante o transporte de materiais e/ou artigos para descontaminação.

6.2 Responsabilidade:

Docentes e Alunos

6.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

6.4 Material necessário:

Bandejas e Container e /ou Organizadores de plástico com tampa.

6.5 Terminologia:

Descontaminação - Processo que pode variar desde um processo de esterilização ou desinfecção até a simples lavagem com água e detergente. Quando se realiza limpeza e desinfecção ou limpeza, desinfecção e esterilização.

6.6 Procedimento:

A) Este procedimento será aplicado para o transporte de materiais e/ou artigos das aulas práticas do laboratório de ensino para o local de descontaminação;

B) Ao final da aula/atendimento, colocar os materiais sujos em bandeja ou no container de plástico com tampa e levar para o local de descontaminação;

C) Levar os materiais/artigos com cuidado para não cair, evitando acidentes pelo caminho;

D) Realizar a descontaminação de cada material, conforme sua classificação, seguidos os PO´s 07, 08 e 09;

D) A supervisão e orientação competem ao Docente responsável.

6.7 Referências

Desenvolvimento interno.

PO Nº 07 - DESCONTAMINAÇÃO DE ARTIGOS CRÍTICOS		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão:001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

7.1 Objetivo:

Definir práticas de condições adequadas para ser realizada a descontaminação de artigos críticos.

OBS: Os ambientes de Saúde e Análises clinicas deverão seguir Portarias e Normas Técnicas Autorizadas pela Anvisa.

7.2 Responsabilidade:

Docentes e Alunos.

7.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

7.4 Material necessário:

1) EPI´S - Toucas / mascaras / avental / luvas / óculos de proteção.
2) Local adequado para Higienização com Pia e Bancada exclusiva / escova de limpeza / Lixeira com pedal e tampa.
3) Frasco com Detergente enzimático / frasco com Hipoclorito de Sódio a 1% frasco com álcool a 70% / frasco com detergente neutro. Obs: manter rótulo de identificação de abertura e seguir normas da ANVISA quanto a local e guarda destes materiais.

4) Bandejas e Container e /ou Organizadores de plástico com tampa - Para acondicionamento do material sujo.

5) Bandejas e Container e /ou Organizadores de plástico com tampa - Para acondicionamento do material limpo.

6) Bandejas e ou containers de plástico com tampa para colocação de materiais de molho nas soluções.

7) Escova de cerdas macias e esponja de limpeza.

8) Papel toalha.

9) Papel grau cirúrgico. (Envelope ou Rolo)

10) Seladora.

11) Caneta para identificação.

12) Impressos para controle de materiais.

13) Autoclave.

7.5 Terminologia:

EPI´S - equipamentos de proteção individual.

Artigos críticos - são os artigos destinados à penetração por meio da pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subpiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados a esse sistema. Esses artigos requerem esterilização.

Contaminação cruzada ou infecção cruzada - refere-se à transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outra, resultando necessariamente em uma infecção.

Descontaminação - processo que pode variar desde um processo de esterilização ou desinfecção até a simples lavagem com água e detergente. Quando se realiza limpeza e desinfecção ou limpeza, desinfecção e esterilização.

Esterilização - destruição de TODAS as formas microbianas, inclusive vírus e esporos bacterianos e fúngicos.

Limpeza - eliminação ou redução de matéria orgânica e sujidades em superfícies e objetos.

7.6 Procedimento

ARTIGOS	EXEMPLOS	PROCESSAMENTOS
CRÍTICOS	● Alicates (de cutícula e de corte), pinças, espátulas de cutícula e podologia, tesoura, cureta, palito de unha de metal, espátulas e pinças para depilação e outros materiais de metal (Bisturis nucleares e de calosidade, fresas).	Limpeza ⇩ Secagem ⇩ Desinfecção ⇩ Acondicionamento ⇩ Esterilização

A) Deixar de molho 5 minutos - para materiais de Beleza e Estética

B) Quando for o caso, limpar os alicates, pinças e espátulas com uma escova de cerdas macias, utilizando a solução de detergente enzimático;

C) Enxaguar abundantemente em água corrente (a remoção inadequada de detergente pode provocar manchas e danos no material).

Secagem:

O material deve ser seco sobre papel toalha limpo;

Pode-se utilizar a autoclave no modo “secagem/dry”;

Embalagem:

a- O material limpo e seco deve ser embalado em envelopes de papel grau cirúrgico próprios para autoclave;

b- A embalagem deve ser bem vedada, utilizando seladora e/ou aba adesiva própria.

c- Na embalagem deve constar uma etiqueta ou carimbo com o nome do material, a data de esterilização e validade, o nome de quem preparou com caneta.

Esterilização:

A) Levar o material para a autoclave em bandejas;

B) Colocar na autoclave e programar o ciclo de esterilização. Devem ser seguidas as orientações do fabricante.

C) Todos os envelopes possuem um indicador químico termossensível, que altera de cor após a passagem pelo processo de esterilização. As cores podem variar de um fornecedor para outro, mas normalmente mudam de azul (antes do processo) para rosa (após o processo). Isso indica que o material passou pelo processo de esterilização.

D) Ciclo de esterilização da autoclave:

A) Consiste em quatro fases: retirada do ar e entrada do vapor; esterilização; secagem; e admissão de ar filtrado para restauração da pressão interna. Os ciclos mais comuns para esterilização em autoclaves são realizados:

TEMPERATURA	**121º C**
DURAÇÃO	**15 A 30 MIN.**
PRESSÃO	**1 ATM**

Estocagem e prazo de validade do artigo estéril:

A) Os envelopes com os artigos devem ser guardados em caixas Plásticas ou Containers ou em armário com portas e limpos até a utilização; A validade de esterilização é de aproximadamente 6 meses, desde que armazenado em local fechado e isento de aberturas e rasuras; A **embalagem deve ser sempre aberta na frente do (a) cliente para evitar a CONTAMINAÇÃO CRUZADA.**

7.7 Referências :

Desenvolvimento interno.

RAMOS, Janine Maria Pereira. **Biossegurança em estabelecimentos de beleza e afins.** 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2009

PO Nº 08 - DESCONTAMINAÇÃO DE ARTIGOS SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS.		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: Ana Valeria G. Reis Coren MS 72.626	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

8.1 Objetivo:

Definir práticas de condições adequadas para ser realizada a descontaminação de artigos semi críticos.

8.2 Responsabilidade:

Docentes e Alunos.

8.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

8.4 Material necessário:

1) EPI´S - Toucas / máscaras / avental / luvas / óculos de proteção.
2) Local adequado para Higienização com Pia e Bancada exclusiva / escova de limpeza / Lixeira com pedal e tampa.
3) Frasco com Detergente enzimático / frasco com Hipoclorito de Sódio a 1% frasco com álcool a 70% / frasco com detergente neutro.

Obs: manter rótulo de identificação de abertura e seguir normas da ANVISA quanto a local e guarda destes materiais.

4) Bandejas e Container e /ou Organizadores de plástico com tampa - Para acondicionamento do material sujo.

5) Bandejas e Container e /ou Organizadores de plástico com tampa - Para acondicionamento do material limpo.

6) Bandejas e ou containers de plástico com tampa para colocação de materiais de molho nas soluções.

7) Escova de cerdas macias e Esponja de limpeza.

8) Papel toalha.

9) Papel grau cirúrgico.

10) Seladora.

11) Caneta para identificação.

12) Impressos para controle de materiais.

13) Autoclave (PARA ARTIGOS SEMI CRÍTICOS).

8.5- Procedimento

ARTIGOS	EXEMPLO	PROCESSAMENTO
SEMI CRÍTICOS	- Escovas e pentes para cabelo, pincéis de maquiagem, toalhas, acessórios de equipamentos.	Limpeza ⇩ Secagem ⇩ Desinfecção ⇩ Acondicionamento ⇩ Esterilização
NÃO CRÍTICOS	Estetoscópios; Esfignomanômetro; Jarros, bacias e cuba rim; comadres; Recipientes e espátulas para aplicação de produtos cosméticos na pele e nos cabelos.	Limpeza Secagem ⇩ Desinfecção ⇩ Acondicionamento

	Acessórios de equipamentos que entram em contato com a pele íntegra.	

A) Higienização das mãos

B) Uso de EPI´s (Touca / mascara / luva / óculos de proteção e Avental ou capote)

C) Lavar os utensílios com auxílio de água, detergente comum e esponja.

***No caso dos acessórios de equipamentos, somente passar pano umedecido com água.**

D) enxaguar abundantemente em água corrente;

E) Secagem; secar naturalmente sobre papel tolha;

REALIZAR ESTERILIZAÇÃO PARA OS ARTIGOS CONSIDERADOS SEMI CRÍTICOS. E DESINFECÇÃO PARA OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.

Desinfecção:

H) Fazer a desinfecção, friccionando papel toalha contendo álcool 70% para os artigos semicríticos

I) **Guardar em local fechado, limpo e seco;**

8.7 Referências :

Desenvolvimento interno.

RAMOS, Janine Maria Pereira. **Biossegurança em estabelecimentos de beleza e afins.** 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

PO Nº 09 - ARTIGOS DE USO ÚNICO		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

9.1 Objetivo:

Definir práticas de condições adequadas para ser realizado o descarte de artigos de uso único.

9.2 Responsabilidade:

Docentes e Alunos.

9.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia.

9.4 Material necessário:

1) EPI´S - Toucas / máscaras / avental / luvas / óculos de proteção.
2) Lixeira específica identificada conforme PO 10 e 11.

9.5 Terminologia:

EPI´S - equipamento de proteção individual

9.6 Procedimento:

Alguns artigos não devem ser processados por métodos de limpeza, desinfecção ou esterilização, pelo fato de perderem suas características originais após o uso, devendo ser, portanto, descartados em lixos específicos, conforme descrito no PO 10 e 11.

Os artigos de uso único não devem ser reaproveitados em outros clientes.

ARTIGOS	EXEMPLO	PROCESSAMENTO
DE USO ÚNICO	Agulhas e lâminas de navalhas e navalhetas; lixas de unhas; palitos de madeira; protetores de bacias; lençóis descartáveis; EPIS (luva, toucas e máscaras). Cateteres para punção venosa; agulhas e seringas; lâminas de bisturi; extensores para cateteres; algodão com sangue; frascos de coleta.	**DESCARTE EM LIXO UNICO CONFORME PO 10 E 11.**

9.7 Referências

Desenvolvimento interno.

RAMOS, Janine Maria Pereira. **Biossegurança em estabelecimentos de beleza e afins.** 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

PO Nº 10 - RESÍDUOS DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO		Emitido: 01/09/2020 Revisado: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

10.1 Objetivo:

Definir o que é resíduo de serviço (RSS) de saúde facilitando sua compreensão, tanto para o usuário interno, quanto o usuário externo do Laboratório de ensino. A definição de resíduos dos Laboratórios de Ensino em Saúde se assemelham aos resíduos produzidos em clínicas e hospitais, apresentando portanto, diversas referências bibliográficas de caráter legal, sanitário, epidemiológico, preventivo e de controle.

A classificação destes resíduos, vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida em que são introduzidos novos tipos de procedimentos em Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia

10.2 Responsabilidade:

Docentes, Alunos e Todos os colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com o processo. (Limpeza e Conservação / logística)

10.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia

10.4 Material necessário:

Nenhum.

10.5 Terminologia:

De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são definidos como geradores de RSS, todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços

onde se realizam atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares.

10.6 Procedimento:

Classificação: De acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05, os RSS são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E, conforme o quadro abaixo:

Grupo A: Resíduos Potencialmente Infectantes Com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. São subdivididos em A1, A2, A3, A4 e A5.	
A1	●Culturas e estoques de microorganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. ●Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou

A1	certeza de contaminação biológica por agentes da classe de risco 4, microorganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causadores de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. ●Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. ●Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

A2	●Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microorganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.
A3	●Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar.
A4	●Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. ●Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.

A4	●Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microorganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons. ●Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. ●Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. ●Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica. ●Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de

	experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações. ●Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.
A5	●Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.

Grupo B: Resíduos Químicos

- Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações.
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes.
- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).
- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

Grupo C: Rejeitos Radioativos

- Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a Resolução CNEN6.05.

Grupo D: Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares (Resíduos comuns)

●Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

●Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de pacientes, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises, equipamento de soro e outros similares não classificados como A1.

●Sobras de alimentos e do preparo de alimentos. Resto alimentar de refeitório.

●Resíduos provenientes das áreas administrativas. Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.

●Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

Grupo E: Resíduos Perfurocortantes

- Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todo utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

10.5 Referências:

Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução RDC nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004: Resíduos Sólidos - Classificação, segunda edição - 31 de maio de 2004.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS 344 de 12 de maio de 1998 - Aprova o regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Radiativas.

Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução RDC nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.6) Comissão Nacional de Energia Nuclear. NE-6.05 - Gerência de Rejeitos em Instalações.

POP Nº 11 - SIMBOLOGIA DOS TIPOS DE RESÍDUOS		Emitido: 01/09/2020 Revisado: Nº da revisão:001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

11.1 Objetivo:

Reconhecer os tipos de resíduos contidos nos sacos e recipientes fornecendo informações para seu correto manejo. Os recipientes de coleta interna e externa, assim como os locais de armazenamento onde são colocados os RSS, devem ser identificados em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de resíduos.

11.2 Responsabilidade:

Docentes, Alunos e Todos os colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com o processo. (Limpeza e Conservação / logística).

11.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia

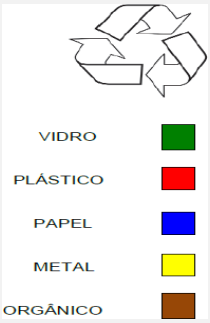
11.4 Terminologia:

Simbologia: Símbolos de identificação dos grupos de resíduos.

1) Os resíduos do **grupo A** são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.



Fig.1 GRUPO A

2) Os resíduos **do grupo B** são identificados através do símbolo de risco associado e com discriminação de substância química e frases de risco.	 **Fig.2 GRUPO B**
3) Os rejeitos do **grupo C** são representados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão MATERIAL RADIOATIVO.	 **Fig.3 GRUPO C**
4) Os resíduos do **grupo D** podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na Resolução CONAMA	 **Fig.4 GRUPO D**

nº 275/01, e símbolos de tipo de material reciclável. Para os demais resíduos do grupo D deve ser utilizada a cor cinza ou preta nos recipientes. Pode ser seguida de cor determinada pela Prefeitura. Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não há exigência para a padronização de cor destes recipientes.	
5) Os produtos do **grupo E** são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo.	 RESÍDUO PERFUROCORTANTE **Fig. 5 GRUPO E**

11.5 Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

PO Nº 12 - ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

12.1 Objetivo:

Esclarecer a forma correta de acondicionar/embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes.

Obs.: 1) A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.

2) Um acondicionamento inadequado compromete a segurança do processo e o encarece. Recipientes inadequados ou improvisados - pouco resistentes, mal fechados ou muito pesados

Se produzidos com materiais sem a devida proteção, aumentam o risco de acidentes de trabalho.

3) Os resíduos não devem ultrapassar 2/3 do volume dos recipientes.

12.2 Responsabilidade:

Docentes, Alunos e Todos os colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com o processo. (Limpeza e Conservação / logística).

12.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia

12.4 Recomendações Gerais:

Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material

resistente a ruptura e vazamento, impermeáveis, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

- Os sacos devem estar contidos em recipientes.
- Os recipientes devem ser de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento.
- Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia não necessitam de tampa para vedação, devendo os resíduos serem recolhidos imediatamente após o término dos procedimentos.
- Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado: resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
- Os resíduos perfurocortantes ou escarificantes - grupo E - devem ser acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa e contendo a simbologia.

12.5 Procedimentos

Acondicionamento Resíduos do Grupo A:

- Os sacos para acondicionamento dos resíduos do grupo A devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. É importante que os recipientes sejam resistentes a tombamento e devem ser respeitados os limites de peso de cada envólucro. Os sacos devem estar identificados com a simbologia da substância infectante e ser de cor branca leitosa. É proibido o esvaziamento dos sacos ou seu reaproveitamento.

- Os resíduos do grupo A, que necessitam de tratamento, precisam ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento a ser utilizado.
- Os resíduos dos grupos A1, A2 e A5 devem ser acondicionados após o tratamento, da seguinte forma:

  1) Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como resíduos do grupo D;

Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados em saco branco leitoso.

Obs: Entende-se por descaracterização física os procedimentos que alteram as características físicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando a minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador.

Acondicionamento de Resíduos do Grupo B:

• **Substâncias perigosas (corrosivas, reativas, tóxicas, explosivas e inflamáveis)** - devem ser acondicionados com base nas recomendações específicas do fabricante para acondicioná-los e descartá-los. Elas se encontram nas etiquetas de cada produto (ler sobre FISPQ abaixo).

• **Resíduos sólidos** - devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico, devendo ser identificados no recipiente de resíduos de acordo com suas especificações.

• **Resíduos líquidos** - devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistente, rígido e estanque, com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados no recipiente de resíduos de acordo com suas especificações.

• O acondicionamento deve observar as exigências de compatibilidade química dos componentes entre si, assim como de cada resíduo com os materiais das embalagens, de modo a evitar reação química entre eles, tanto

quanto o enfraquecimento ou deterioração de tal embalagem, ou a possibilidade de que seu material seja permeável aos componentes do resíduo. Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de polietileno de alta densidade - PEAD, deverá ser observada a compatibilidade entre as substâncias.

- Os resíduos que irão ser encaminhados para reciclagem ou reaproveitamento devem ser acondicionados em recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química do resíduo com os materiais das embalagens, de forma a evitar reação química entre seus componentes e os da embalagem, tanto quanto o enfraquecimento ou deterioração da mesma. Não se deve permitir que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo.
- Devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico, e identificados através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.
- As embalagens secundárias, que não entraram em contato com o produto, devem ser fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como resíduo do grupo D. Devem ser preferencialmente encaminhadas para processo de reciclagem.
- As embalagens primárias, secundárias e os materiais contaminados por substância química devem ter o mesmo tratamento das substâncias químicas que as contaminaram.
- Os resíduos contendo mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob selo d'água e encaminhados para recuperação.
- Os disquetes não mais utilizados devem ser acondicionados como recicláveis, com o objetivo de reciclar o plástico e o metal neles existentes. Para os cartuchos de impressão, sempre que possível,

deve-se buscar empresas que prestam o serviço de recarga. Caso não haja possibilidade de recarga, o mesmo deve ser acondicionado como resíduo do grupo D. Pode ser utilizado o plástico dos resíduos para reciclagem, com emissão de certificado de recolhimento.

- As lâmpadas fluorescentes devem ser acondicionadas separadamente do restante dos resíduos, para que sejam enviadas à reciclagem, com emissão de certificado de recolhimento. Pilhas e baterias devem ser encaminhadas ao setor de manutenção.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

- A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) contém informações sobre o transporte, manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. Em alguns países, essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet - MSDS.
- A FISPQ possui 16 seções, cuja terminologia, numeração e seqüência atendem a norma brasileira NBR 14725.
- Em todos os locais onde são utilizados ou manipulados produtos químicos, deverão possuir a FISPQ de cada produto em lugar visível e acessível para em caso de emergência se tratando de acidentes, sejam eles, materiais ou pessoais possam ser consultados/manuseados para que se possa proceder às medidas cabíveis em cada situação apresentada.
- Os Colaboradores deverão ter ciência do conteúdo da FISPQ e porque elas se encontram afixadas no setor.

Acondicionamento de Resíduos do grupo C:

Rejeitos radioativos - devem ser acondicionados em recipientes de chumbo, com blindagem adequada ao tipo e ao nível de radiação emitida, e ter a simbologia de radioativo.

- Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, forrados internamente com saco plástico resistente e identificados conforme o item 12.2 da RDC ANVISA nº 306/04.

  Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em frascos de até dois litros ou em bombonas de material compatível com o líquido armazenado, sempre que possível de plástico, resistente, rígido e estanque, com tampa rosqueada, vedante. Eles devem ser acomodados em bandejas de material inquebrável e com profundidade suficiente para conter, com a devida margem de segurança, o volume total do rejeito, e ser identificados com símbolos específicos.

- Após o decaimento do radionuclídeo passam a ser resíduos e serão classificados de acordo com o material a que o radionuclídeo estiver associado.

Acondicionamento de Resíduos do grupo D:

- Resíduos com características semelhantes aos domiciliares – devem ser acondicionados em sacos impermeáveis, de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana. Na ESCOLA SENAC HORTO, estes resíduos devem ser acondicionados em sacos de lixo de cor preta.

- Os cadáveres de animais devem ter acondicionamento e transporte diferenciados, de acordo com o porte do animal, desde que submetidos à aprovação pelo órgão de limpeza urbana, responsável direto ou coordenador das etapas de coleta, transporte e disposição final.

Acondicionamento de RSS do grupo E:

- Para os resíduos cortantes ou perfurantes, o pré-acondicionamento deve ser em recipiente rígido, estanque, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa, contendo a simbologia da substância.
- Os materiais perfurocortantes devem ser acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso.
- É expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento.

  É proibido reencapar ou proceder a retirada manual das agulhas descartáveis.

- Os recipientes que acondicionam os PERFUROCORTANTES devem ser descartadas quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 cm de distância da boca do recipiente, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
- Quando o gerador de Resíduos gerar material perfurocortante dos grupos A E B, poderá ser utilizado um único recipiente de acondicionamento na unidade geradora, sendo que, para o descarte, deverá ser considerado o resíduo de maior risco.
- Os resíduos do grupo E, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, recolhidos pelo serviço de assistência domiciliar, responsável pelo gerenciamento desse resíduo.

Exemplos de resíduos e suas identificações específicas:		
Símbolo de identificação	**Exemplo de resíduos**	**Descarte**
	**Resíduos comuns (Grupo D)** Papéis, papel toalha e lençóis descartáveis usados e não contaminado com material biológico, restos de alimentos, embalagens de produtos cosméticos não tóxicos, caixas de papelão, latas e plásticos em geral.	Em lixeira comum lavável, com tampa e pedal e com o símbolo de identificação específica. O **saco de lixo pode ser preto ou azul.** **Podem ser recicláveis e não recicláveis.**
	Resíduos infectantes **Risco biológico (grupo A)** Unhas, cutículas, palitos de unhas, cabelos, cera com pelos, luvas, máscaras, toucas, algodão, gazes, lençóis descartáveis e papéis protetores de macas contaminados com material biológico.	Em lixeira comum lavável, com tampa e pedal e com o símbolo de identificação específica. O **saco de lixo deve ser branco ou pode ser descartado no descartex.**
	**Risco perfurocortantes (grupo E)** Agulhas, lâminas de bisturi, pinças, navalhas, tesouras, espátulas e alicates de metal, cortadores de unha e todos os	**Em descartex.**

12.6 Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14725: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos- FISPQ – julho de 2001.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília, 2006.

Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução RDC nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

POP Nº 13 - NORMAS INTERNAS PARA ACIDENTES		Emitido: 22/08/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Sandra Lara e Ana Valeria**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

13.1 Objetivo:

Estabelecer medidas de Urgência em Primeiros Socorros para atendimento aos docentes, funcionários ou alunos expostos a Acidentes Físicos / Mecânicos e Agentes Químicos e Biológicos.

13.2 Responsabilidade:

Docentes / Alunos e Colaboradores.

13.3 Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia

13.4 Material necessário:

Água e sabão

Papel Toalha

Compressa de Gaze

Hipoclorito de Sódio a 0,5%

Sacos autoclaváveis – para produtos biológicos.

Impresso com checklist de exposição à contaminação.

Material para atendimento em Primeiros Socorros.

13.5 Terminologia:

Primeiros socorros: são os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, quando seu estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de preservar suas funções

vitais e evitar o agravamento de sua situação, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência médica qualificada.

Perfurocortante: São seringas, agulhas, escalpes, ampolas, vidros de um modo geral ou, qualquer material pontiagudo ou que contenha fios de corte capazes de causar perfurações ou cortes.

Acidente: é um evento súbito e inesperado do qual resultam consequências indesejáveis.

13.6 Procedimento:

- Para evitar o Risco de acidente em qualquer ambiente de aprendizagem, todos deverão seguir de forma responsável as normas e recomendações preconizadas no POP 01 e 02 deste manual.

- A prestação de primeiros socorros não exclui de forma alguma a avaliação de um médico, sendo de fundamental importância o atendimento clínico. Portanto após o ocorrido a vítima, deve ser encaminhada ao Pronto Atendimento mais **próximo prioritariamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU / LIGAR PARA 192. Ou em carro próprio ACOMPANHADA.**
- **Outros telefones que poderão ser úteis durante o atendimento:**
  CORPO DE BOMBEIROS – 193
  CIVITOX: (67) 3386-8655 ou 0800 722 6001.
- Na maioria dos casos a pessoa que inicia os procedimentos é normalmente aquela que presenciou ou chegou instantes depois do fato, e sendo assim, precisa manter a calma para agir sem pânico, com rapidez, precisão e precaução, atento a condições que não piorem o estado da vítima.
- No derramamento de material biológico em piso ou bancada, despeje hipoclorito de sódio a 0,5% em torno do material, coloque um papel toalha ou gaze for cima aguarde 20 minutos no mínimo e recolha colocando em sacos autoclaváveis, para realizar a autoclave e o descarte final.
- Em casos de produtos químicos, limpar o local imediatamente com água em abundância, ventilar o local , se o produto for tóxico evacuar o local e usar máscara na operação da limpeza. Os resíduos da limpeza ou materiais impregnados devem ser descartados como resíduos químicos.
- Contato de substâncias químicas com a pele e olhos - PELE: lave o local abundantemente com água, no mínimo por 15 minutos. Retire a roupa e

objetos atingidos pelo produto. Procure o serviço médico o mais rápido possível, levando o rótulo. Remova as roupas atingidas sob o chuveiro. Lave a área do corpo afetada com água fria por 15 minutos ou enquanto persistir dor ou ardência. Lave a área afetada com sabão neutro e água (não use loções, creme, soluções neutralizantes, etc). - OLHOS: lave os olhos afetados, por pelo menos 15 minutos, com água fria. Encaminhe a vítima ao atendimento médico de emergência. Informe o produto químico envolvido no acidente, levando o rótulo.

- Exposições com produtos químicos que causem queimadura, identifique o tipo e a extensão das queimaduras na vítima. Em casos de grande área afetada, queimaduras muito severas (terceiro grau) ou queimadura com materiais perigosos (produtos químicos), chame imediatamente o socorro especializado (Corpo de Bombeiros - 193, SAMU - 192). Retire a roupa da vítima que não estiver grudada. Caso esteja grudada, não retire, pois podem ser ocasionadas lesões mais graves. Retire objetos da vítima que possam ser removidos, tais como correntes, relógios, etc. Se estiverem grudados, não os retire. Se a queimadura for por substância sólida, retire o excesso com pano seco. Proteja a si mesmo durante o processo. Lave em água corrente e limpa, abundantemente e sem fazer pressão, as áreas queimadas e arredores, para aliviar a dor e retirar o excesso de calor e de substâncias químicas. Proteja o local afetado com uma compressa e molhada em água limpa.
- Acidentes com perfurocortantes, recomenda-se lavar imediatamente com muita água e sabão líquido neutro, cobrir com gaze estéril e procurar, imediatamente, atendimento médico.
- Com quebras de vidrarias e cortes é necessário primeiramente cuidar do ferimento, como no perfurocortantes, depois se os cacos estiverem na bancada, recolher com pinça, se estiver no chão recolher com um esfregão umedecido com desinfetante e uma pá. Coloque o material em um recipiente de paredes rígidas. Encaminhar a vítima seguindo as normas de atendimento descritas no início deste POP.
- Em caso de ferimentos cortantes ou perfurantes superficiais, deve-se lavar o local com água abundante e sabão, até que a vítima seja direcionada para atendimento médico. Em caso de lesões mais profundas com hemorragia, deve-se comprimir ou envolver a região acometida com compressa, promovendo hemostasia, até que a vítima seja encaminhada para atendimento hospitalar. Lembrando que, preferencialmente, a pessoa que fará este socorro imediato deverá estar portando luvas para sua própria proteção. Com quebras de vidrarias, se

os cacos estiverem na bancada, recolher com pinça, se estiver no chão recolher com um esfregão umedecido com desinfetante e uma pá. Coloque o material em um recipiente de paredes rígidas.

- Em casos de acidentes com vidrarias na centrífuga, aguardar uns 30 minutos até o aerossol baixar. Colocar os EPIs, descontaminar o suporte da centrífuga e a parte interna do equipamento com hipoclorito de sódio a 0, 5% ou álcool 70% por no mínimo 15 minutos, retirar os demais tubos, descartar os fragmentos em recipiente para perfurocortantes, comunicar o incidente ao responsável.
- No caso de acidentes com substâncias químicas ou biológicas, se for sobre a mucosa ocular, não friccionar os olhos e lavá-los imediatamente no lava-olhos com muita água no mínimo 15 minutos ou até que a substância seja totalmente removida, se o acidentado estiver usando lentes retirar apenas após a lavagem e então procurar o oftalmologista com o nome do produto químico ou o material biológico.
- Se o acidente for sobre o corpo entrar imediatamente debaixo do chuveiro de emergência, por no mínimo 15 minutos ou até que a substância seja removida, caso ocorra queimaduras, cobrir a área afetada com vaselina estéril e procurar atendimento médico com o nome do produto químico ou material biológico.
- Acidente por Ingestão de agentes químicos cáusticos ou tóxicos por via oral, a vítima deverá ser encaminhada imediatamente ao atendimento médico para avaliação. Não fazer a vítima ingerir água, leite ou qualquer outra substância sem orientação médica.
- Em todos os casos de acidentes descritos acima ou outros que envolvam material biológico deve-se comunicar ao coordenador de curso para encaminhar a vítima ao local de referência para tratamento.
- É importante que para os laboratórios, todos que frequentam os mesmos, estejam cientes, que o local possui uma BRIGADA de incêndio, e quem é o BRIGADISTA responsável, além de saber as rotas para evacuação do prédio no caso de incêndio.
- No caso específico de paradas cardiorrespiratórias, a urgência e o tempo de atendimento são vitais para a sobrevivência, recuperação e minimização de sequelas nas vítimas. As chances de salvamento de uma vítima de choque elétrico com parada cardiorrespiratória diminuem com o passar do tempo.
- Por isso, a identificação de uma vítima de choque elétrico que sofreu parada cardiorrespiratória (PCR) é prioritária, assim como a aplicação dos corretos procedimentos de reanimação.

- Atualmente, as diretrizes recomendam identificar inicialmente a parada cardíaca e, caso presente, deve-se iniciar imediatamente o procedimento de reanimação com massagem cardiorrespiratória. Tal procedimento deve ser executado continuamente, até a chegada da equipe médica especializada, ou até que a pessoa recobre a consciência, com batimentos cardíacos e respiração normais.
- **Identificação de PCR (Parada Cardiorrespiratória):** Para identificar que o paciente não possui atividade cardíaca, deve-se checar as seguintes condições:

  1. Verificar se a vítima não responde a estímulos externos, tais como o chamar pelo nome, ou a resposta a pequenos tapas no rosto.
  2. Verificar a ausência de batimento cardíaco, seja por ausculta do coração, através de palpação do pulso ou da artéria carótida ou através da constatação da ausência de movimentos de contração da pupila frente às variações de intensidade de luz.
- Caso as duas condições acima sejam verificadas (inconsciência e ausência de batimentos cardíacos), deve-se proceder IMEDIATAMENTE aos procedimentos de MASSAGEM CARDÍACA E REANIMAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, além da chamada dos serviços de emergência especializados (Corpo de Bombeiros - 193, SAMU - 192 ou Polícia - 190).
- **Procedimento de Massagem Cardiorrespiratória -** Caso não haja atividade cardíaca, o procedimento de reanimação através de massagem cardiorrespiratória consiste em aplicar a **Massagem cardíaca combinada com a respiração artificial,** executadas da seguinte forma:



13.7 Referências:

- ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Biossegurança. Rev. Saúde Pública, 2005; 39(6)989-91.
- ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança e Controle de Qualidade no Laboratório de Microbiologia Clínica. Rev. Saúde Pública, 2004.
- ARAÚJO, L. G. S. F. MEDEIROS, G. Biossegurança em Laboratório. Revista Inovação, Teresina, v. 1, n. 1, p. 45-51, 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com Agentes Biológicos. Brasília: Editora MS, 2006.
- OTUKI, Cassyano J Correr; Michel F. MÉTODO CLÍNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS. 2016. Disponível em: Acesso em: 24 ago. 2020.
- ZOCHIO, L. B. Biossegurança em laboratórios de análises clínicas. São José do Rio Preto: Academia de ciências e tecnologia, 2009.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 23 de Jul de 2015, disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58168/pcdt_pep_hiv_versao_p reliminar_26agosto2015_pdf_49775.pdf Acesso em: 24 de ago. 2020.

ANEXO 1 - TABELA LIMPEZA DOS AMBIENTES		Emitido: 22/08/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: Ana Valeria G. Reis Coren MS 72.626	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

	DIÁRIA	SEMANAL	QUINZENAL	MENSAL	TRIMESTRAL	APÓS USO
ÁREAS E SUPERFÍCIES FIXAS / MOBILIÁRIOS / EQUIPAMENTOS						
LIXEIRA	Ẋ					Ẋ
PISO	Ẋ					Ẋ
EXTINTOR DE INCÊNDIO		Ẋ				
PORTAS E JANELAS			Ẋ			
PAREDES E TETOS				Ẋ		
PERSIANAS				Ẋ		
MAÇANETAS DE PORTA	Ẋ					Ẋ
INTERRUPTORES DE ENERGIA	Ẋ					Ẋ
PIAS E VASOS SANITÁRIOS	Ẋ					Ẋ
MESAS	Ẋ					Ẋ

BANCADAS	**X**					**X**
BALCÕES	**X**					**X**
CADEIRAS	**X**					**X**
MACAS E MOCHOS	**X**					**X**
VIDROS E ESPELHOS		**X**				
ARMÁRIOS			**X**			
LUMINÁRIAS				**X**		
TELEFONES E IMPRESSORAS	**X**					**X**
COMPUTADORES	**X**					**X**
AUTOCLAVES						**X**
EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA	**X**					**X**
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	**X**					**X**
EQUIPAMENTOS DE PODOLOGIA	**X**					**X**
SECADORES E CHAPINHAS	**X**					**X**

ANEXO 2 - DESINFECÇÃO ESCOVAS E PENTES		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: Ana Valeria G. Reis Coren MS 72.626	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

ARTIGO SEMI CRITICO – SALÃO DE BELEZA

ESCOVAS E PENTES PARA CABELO.

ETAPAS	PROCEDIMENTO
LIMPEZA 	1) Remover os fios de cabelo após o uso. 2) Lavar com água e detergente*. 3) Deixar de molho por 10 min. 4) Proceder a fricção mecânica. 5) Enxaguar em água abundante.
SECAGEM	Natural ou com secador de cabelos.
DESINFECÇÃO	Fazer a desinfecção friccionando a toalha tendo álcool 70% Guardar em local limpo e seco.

* (NA PROPORÇÃO 1 COLHER DE SOPA DE DETERGENTE PRA 1 LITRO DE ÁGUA.)

ANEXO 3 - DESINFECÇÃO PINCÉIS DE MAQUIAGEM		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001
Elaborado: Ana Valeria G. Reis Coren MS 72.626	Verificado: Cynthia Antonielly CRFMS 2119	Aprovado:

ARTIGO SEMI CRITICO – SALÃO DE BELEZA

PINCÉIS DE MAQUIAGEM

ETAPAS	PROCEDIMENTO
LIMPEZA  São de uso individual; portanto, não podem ser reutilizados em outro cliente sem a devida limpeza e desinfecção.	Por possuírem cerdas delicadas, deve-se utilizar para a limpeza o detergente enzimático, ou, utilizar xampus para bebê. Mergulhar os materiais sujos em uma cuba, contendo solução de 0,5% de detergente enzimático ou xampu para bebê; Deixar de molho durante 5 minutos; Massagear as cerdas a fim de retirar restos de produtos e sujidades; Enxaguar abundantemente com água corrente;
SECAGEM	Borrifar e umedecer o papel toalha; Esfregue, cuidadosamente, o pincel no papel toalha em movimentos de vai e vem; Em seguida, seque-o em papel toalha seco; Na haste do pincel, borrifar álcool 70%;
DESINFECÇÃO	Nas cerdas, fazer a desinfecção com higienizador de pincéis, que contém álcool 70%, glicerina e água (específico para cerdas de pincel).

* (NA PROPORÇÃO 1 COLHER DE SOPA DE DETERGENTE PRA 1 LITRO DE ÁGUA.)

ANEXO 4 - COLETA E TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 001/2023
Elaborado: **Ana Valeria G. Reis** **Coren MS 72.626**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

Objetivo:

A coleta e transporte interno dos resíduos, consistem no translado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento temporário (expurgo) ou armazenamento externo (abrigo externo), com a finalidade de disponibilização para a coleta.

É nesta fase que o processo se torna visível para o usuário e o público em geral, pois os resíduos são transportados nos equipamentos de coleta (carros de coleta) em áreas comuns.

Setor:

Ambientes da Saúde, Beleza, Estética e Podologia

Material necessário:

Carro e kit de limpeza.

Procedimento:

- A coleta e o transporte devem atender ao roteiro previamente definido e devem ser feitos em horários, sempre que factível, não coincidentes com maior fluxo de pessoas ou de atividades.
- A coleta deve ser feita separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos.
- A coleta interna de RSS deve ser planejada com base no tipo de RSS, volume gerado, roteiros (itinerários), dimensionamento dos abrigos, regularidade, freqüência de horários de coleta externa.
- Deve ser dimensionada considerando o número de funcionários disponíveis, número de carros e kits de limpeza, EPIs e demais ferramentas e utensílios necessários.

- O transporte interno dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou risco de acidente para o funcionário.
- Após as coletas, o colaborador responsável pela ação, deve lavar as mãos ainda enluvadas, retirar as luvas e colocá-las em local próprio. Ressalte-se que o colaborador também deve lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las.
- Os equipamentos para transporte interno (carros de limpeza) devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, rodas revestidas de material que reduza o ruído.
- Também devem ser identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido.

Recomendações específicas para coleta interna:

•Os carros de limpeza devem ter, preferencialmente, pneus de borracha e estar devidamente identificados com símbolos de risco;

• Estabelecer turnos, horários e frequência para coleta;

• Sinalizar o itinerário da coleta de forma apropriada;

• Não utilizar transporte por meio de dutos ou tubos de queda;

• Diferenciar as coletas, isto é, executá-las com itinerários e horários diferentes segundo o tipo de resíduo;

• Coletar resíduos recicláveis de forma separada;

• Dependendo da distância entre os pontos de geração de resíduos e do armazenamento externo, poderá ser dispensado o armazenamento temporário, sendo o encaminhamento direto ao armazenamento para coleta externa.

• Dependendo da distância entre os pontos de geração de resíduos e do armazenamento externo, poderá ser dispensado o armazenamento temporário, sendo o encaminhamento direto ao armazenamento para coleta externa.

• Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso ou sobre piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.

• Dependendo da distância entre os pontos de geração de resíduos e do armazenamento externo, poderá ser dispensado o armazenamento

temporário, sendo o encaminhamento direto ao armazenamento para coleta externa.

• Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso ou sobre piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.

• Quando o armazenamento temporário for feito em local exclusivo, deve ser identificado como sala de resíduo que pode ser um compartimento adaptado para isso, caso não tenha sido concebida na construção, desde que atenda às exigências legais para este tipo de ambiente.

Recolhimento do lixo (coleta interna II) - Seguir Manual Específico.

8.6 Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília, 2006.

ANEXO 5 – TELEFONES ÚTEIS		Emitido: 01/09/2020 Próxima Revisão: Nº da revisão: 01/2023
Elaborado: **Sandra Lara**	**Verificado:** Cynthia Antonielly CRFMS 2119	**Aprovado:**

TELEFONES ÚTEIS	
193	CORPO DE BOMBEIROS: Atendimento a incêndios e casos de emergências com produtos químicos ou acidentes
199	DEFESA CIVIL: Prevenir e minimizar os efeitos de desastres, sejam eles naturais ou provocados pelo homem.
192	*SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) A*tender casos de emergências clínicas (mal súbito, convulsões, infarto, etc.)
(67) 3318-1670; 3381-2996; 3378-2558	CIVITOX - Centro Integrado de Vigilância Toxicológica de Campo Grande – Atender a orientações em caso de intoxicação por agentes químicos.
0800 722 7272	ENERGISA - Atendimento da distribuidora de energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul. (Atendimento 24 horas)
0800 642 0115	ÁGUAS GUARIROBA - Atendimento da empresa de abastecimento de água no estado de Mato Grosso do Sul. (Atendimento 24 horas).
190	POLICIA MILITAR – Restabelecer a ordem pública e auxiliar nos casos de orientações emergenciais.
153	GUARDA MUNICIPAL - Restabelecer a ordem pública e auxiliar nos casos de orientações emergenciais.